

DANS CE SUJET

+

AUTRES SUJETS DANS CE CHAPITRE

→

Perte brutale de la vision

→

Anisocorie

→

Vision trouble

→

Diplopie

→

Œdème des paupières

→

Douleur oculaire

→

Corps flottants

→

Exophtalmie

→

Œil rouge

→

Larmoiement

→

Autres symptômes oculaires

Corps flottants



Par **Christopher J. Brady**, MD, Larner College of Medicine, University of Vermont
Reviewed By **Sunir J. Garg**, MD, FACS, Thomas Jefferson University

Vérifié/Révisé oct. 2025

Physiopathologie | Étiologie | Bilan | Traitement | Points clés | Multimédia

Les corps flottants sont des opacités qui bougent à travers le champ visuel et ne correspondent pas à des objets visuels extérieurs.

Physiopathologie des corps flottants

Avec le vieillissement, le vitré peut se contracter et se détacher de la rétine. L'âge auquel cette modification survient est variable, mais le plus souvent, entre 50 et 75 ans. Pendant cette séparation, le vitré peut par intermittence tirer fortement sur la rétine. Les tractions mécaniques stimulent la rétine, qui envoie un signal qui est perçu par le cerveau et interprété comme de la lumière. La séparation complète du vitré conduit à une augmentation des corps flottants, qui peut durer plusieurs années.

Cependant, une traction sur la rétine peut créer un trou (déchirure rétinienne) et si du liquide passe sous la déchirure, la rétine peut se détacher. Le **décollement de la rétine** peut également être causé par d'autres facteurs (p. ex., un traumatisme, une maladie primitive de la rétine). Les impressions lumineuses brèves, qui ressemblent à des éclairs, fréquentes dans le décollement de la rétine, sont appelées photopsies. Les photopsies peuvent également survenir lorsqu'on se frotte les yeux ou lorsqu'on regarde alentour après le réveil (1).

Référence pour la physiopathologie

1. Flaxel CJ, Adelman RA, Bailey ST, et al. Posterior Vitreous Detachment, Retinal Breaks, and Lattice Degeneration Preferred Practice Pattern®. *Ophthalmology*. 2020;127(1):P146-P181. doi:10.1016/j.ophtha.2019.09.027

Étiologie des corps flottants

La cause **la plus fréquente** des corps flottants est

- Contraction idiopathique de l'humeur vitrée

Les causes moins fréquentes sont énumérées dans le tableau **Certaines causes de corps flottants**.

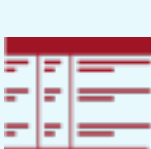
Les causes rares de corps flottants comprennent les tumeurs intra-oculaires (p. ex., lymphome) et une vitrite (inflammation du vitré). Les corps étrangers intra-oculaires peuvent provoquer des corps flottants mais habituellement ils se manifestent par d'autres symptômes, tels que perte de la vision, douleurs oculaires ou rougeur du globe.

Évaluation des corps flottants

L'objectif le plus important est d'identifier les lésions sérieuses du vitré et de la rétine. Si ces lésions ne peuvent être écartées, les patients doivent être examinés par un ophtalmologiste utilisant un ophtalmoscope indirect après dilatation pupillaire chaque fois que possible. Savoir reconnaître une migraine ophtalmique est également utile.

TABEAU

[Certaines causes de corps flottants](#)



Anamnèse

L'**anamnèse de la maladie actuelle** doit établir le début et la durée des symptômes, la forme et le volume des corps flottants, s'ils sont uni- ou bilatéraux et s'ils ont été précédés d'un traumatisme. Le patient doit essayer de différencier les corps flottants des phénomènes lumineux semblables à des éclairs (comme dans les photopsies) ou des lignes brisées dans le champ visuel (comme dans la migraine). Les symptômes associés importants comprennent l'altération de vision (et sa distribution dans le champ visuel) et la douleur oculaire.

La **revue des systèmes** doit rechercher les symptômes des causes possibles, tels que des céphalées (migraine ophtalmique) et un œil rouge (inflammation du vitré).

La **recherche des antécédents médicaux** doit porter sur un **diabète** (dont une **rétinopathie diabétique**), des **migraines**, une chirurgie oculaire, une myopie grave, la prise de drogues par injection et toutes les maladies qui pourraient affecter le système immunitaire.

Examen clinique

L'examen ophtalmologique doit être raisonnablement complet. L'acuité visuelle la mieux corrigée est mesurée. Les globes sont inspectés pour vérifier s'ils sont rouges. Les champs visuels sont contrôlés chez tous les patients. Cependant, reconnaître des anomalies du champ visuel par examen au lit du malade est très incertain, et l'incapacité à détecter une telle anomalie ne permet pas d'affirmer que les champs visuels du patient sont normaux. Les mouvements oculaires et la réponse pupillaire à la lumière sont évalués. Si les patients ont un œil rouge ou des douleurs oculaires, les cornées sont examinées sous grossissement après coloration à la fluorescéine, et un examen à la lampe à fente est effectué si possible. La tension oculaire est mesurée (tonométrie).

L'ophtalmoscopie est la partie la plus importante de l'examen; elle est pratiquée après la dilatation des pupilles. Pour dilater les pupilles, le médecin s'assure d'abord de noter la taille de la pupille et ses réponses à la lumière, puis instille des gouttes, habituellement 1 goutte d'un agoniste alpha-adrénérique à courte durée d'action et d'un cycloplégique. Les pupilles sont complètement dilatées environ 20 min après que ces gouttes ont été instillées. L'examen du fond de l'œil est effectué par un non-ophtalmologiste par ophtalmoscopie directe. Un ophtalmologiste pratique une ophtalmoscopie indirecte, qui permet une visualisation plus complète de la rétine, en particulier de la périphérie.

Signes d'alarme

Les signes suivants sont particulièrement préoccupants:

- Augmentation soudaine des corps flottants
- Photopsies
- Baisse de vision, diffuse ou focale (anomalie du champ visuel)
- Une chirurgie oculaire récente ou un traumatisme oculaire récent
- Douleur oculaire
- Perte du reflet rouge de la pupille
- Anomalies rétiniennees au fond d'œil

Interprétation des signes

Le **décollement de la rétine** est suspecté devant une brutale augmentation des corps flottants, des photopsies ou toutes autres caractéristiques plus spécifiques (p. ex., un trouble du champ visuel, des anomalies rétiniennees). Des symptômes bilatéraux synchrones suggèrent une migraine ophtalmique, bien que les patients aient souvent du mal à décoder la latéralité de leurs symptômes (p. ex., ils interprètent souvent un scotome scintillant de la partie gauche des deux champs visuels comme affectant le seul œil gauche). La perte de reflet rouge de la pupille suggère une opacification du vitré (p. ex., hémorragie ou inflammation du vitré), mais elle peut également être causée par une cataracte avancée. La perte de la vision suggère une maladie grave provoquant un dysfonctionnement du vitré ou de la rétine.

Examens complémentaires

Les patients qui nécessitent un examen par un ophtalmologiste peuvent avoir besoin d'examens complémentaires. Cependant, ces examens peuvent être choisis par ou en association avec l'ophtalmologiste. Par exemple, les patients suspectés d'avoir une choriorétinite peuvent avoir besoin d'examens bactériologiques.

Traitement des corps flottants

Les corps flottants idiopathiques ne nécessitent aucun traitement. Les autres maladies responsables de ces symptômes sont traitées.

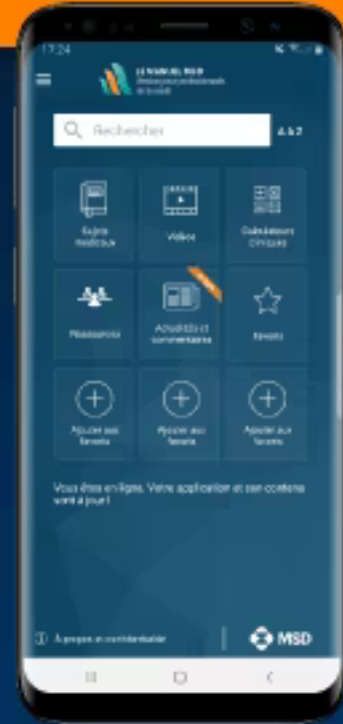
Points clés

- Les corps flottants par eux-mêmes indiquent rarement une maladie grave.
- Tous les patients qui présentent des symptômes anormaux à l'examen doivent être adressés à l'ophtalmologiste.
- Si les corps flottants sont accompagnés d'autres symptômes (p. ex., persistance de points lumineux, anomalie de la vision, sensation de perte visuelle en rideau mobile) ou s'ils se développent soudainement, les patients doivent être adressés à l'ophtalmologiste quels que soient les signes à l'examen.



TESTEZ VOS CONNAISSANCES
Répondez à un questionnaire sur ce sujet

Téléchargez gratuitement l'application Manuels MSD



Scannez le code pour télécharger dès maintenant

